

Les syndromes pleuraux

Dr N. BOULEKROUNE

Plan du cours

-  **Part 01 :**
 - Objectifs pédagogiques
 - Généralités**
 - Introduction/ Définition
 - Rappel anatomique

-  **Part 02 :**
 - Le syndrome d'épanchement pleural liquidien
 - Démarche diagnostique**
 - Le syndrome d'épanchement pleural aérien
 - Le syndrome d'épanchement pleural mixte

-  **Part 03 :**
 - Points à retenir
 - Conclusion**
 - Références

Objectifs pédagogiques



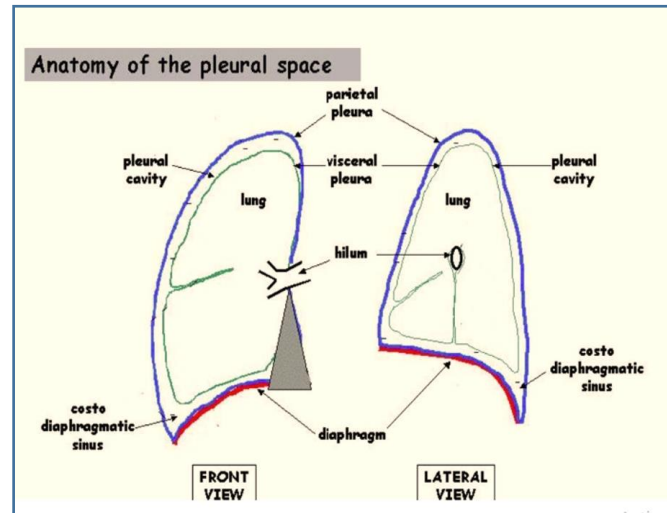
1. Définir les syndromes pleuraux.
2. Identifier les signes fonctionnels et physiques.
3. Différencier entre le syndrome pleural liquidien et aérien.

I. Introduction/ Définition

- ✚ Définition d'un syndrome : ensemble de signes cliniques et/ou paracliniques regroupant plusieurs étiologies.
- ✚ Classification des syndromes respiratoires : elle est anatomique (bronches, poumons, plèvres, médiastin et parois).
- ✚ Syndrome pleural : se définit par un ensemble de signes cliniques et paracliniques traduisant la présence anormale de liquide, d'air, ou de tissu dans tout ou partie de la cavité pleurale.

II. Rappel anatomique :

- La plèvre :
- ✚ Comprend deux feuillets (pariétal et viscéral) délimitant un espace virtuel.
- ✚ Contenant une fine lame de liquide pleural dont la production est de 5-20 cc/j par la plèvre pariétale, permet le glissement des 2 feuillets l'un contre l'autre et produit.
- Dans les situations pathologiques :
- ✚ La cavité pleurale n'est plus virtuelle.
- ✚ Selon son contenu, on parlera de :
 - Pleurésie : si elle contient du liquide.
 - Pneumothorax : si elle contient de l'air.
 - Hydro-pneumothorax : si elle contient du liquide et de l'air.



III. Démarche diagnostique

A) Le syndrome d'épanchement pleural liquidien (pleurésie)

A-1) Définition :

- ✚ La pleurésie définit la présence de liquide entre les 2 feuillets de la plèvre.
- ✚ Provoqué par un déséquilibre entre la formation du liquide pleural et la capacité des feuillets pleuraux à le résorber.
- ✚ La symptomatologie clinique varie en fonction de l'abondance de l'épanchement.
- ✚ Le diagnostic positif d'une pleurésie est suspecté sur les données cliniques et confirmé par la radiologie et la ponction pleurale qui ramène du liquide.

A-2) Circonstances de découverte :

- ✚ Découverte fortuite : à l'occasion de la réalisation du radio du thorax ou scanner thoracique.
- ✚ Devant des signes d'appel :
 - Signes généraux (dépendent de l'étiologie) : fièvre, sueurs, altération de l'état général.
 - Signes fonctionnels (surtout s'il est d'installation aiguë) :
 - Une douleur : basithoracique à type de point de côté (signe le plus fréquent), survenant à : l'inspiration profonde ou à la toux, augmentant aux changements de position et irradiant dans l'épaule.
 - Une toux : sèche, quinteuse, souvent déclenchée par les changements de position.
 - Une dyspnée : de type de tachypnée superficielle et ce d'autant plus que l'épanchement est abondant et que le poumon sous-jacent est malade.

- ✚ Plus rarement, lors d'une complication.

A-3) Examen physique : comporte plusieurs volets, on retrouve à ;

- ❖ L'inspection : une diminution de l'ampleur thoracique homolatérale.
- ❖ La palpation : une abolition des vibrations vocales.
- ❖ La percussion : une matité franche, hydrique, de bois en regard de l'épanchement.
- ❖ L'auscultation : une abolition ou diminution de murmure vésiculaire.

A-4) Radiographie du thorax :

- ✚ Indispensable devant toute suspicion de pleurésie.
- ✚ L'épanchement pleural est facilement identifiable à partir de 150 cc sur les clichés pulmonaires de face.
- ✚ Le liquide pleural s'accumule dans la partie déclive du thorax.

➡ **Mais la présentation clinique et radiologique peut varier en fonction de l'abondance de l'épanchement**

A-5) Pleurésie de grande abondance :

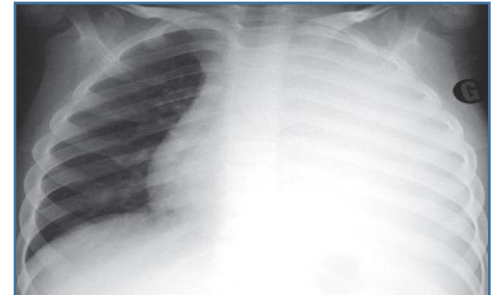
A-5-1) **Examen physique** : comporte plusieurs volets, on retrouve à ;

- ❖ L'inspection : diminution de l'ampliation thoracique homolatérale, distension nette de l'hémithorax atteint, élargissement marqué des espaces intercostaux.
- ❖ La palpation : une abolition des vibrations vocales.
- ❖ La percussion ++ : représente le temps fondamental de l'examen.
 - ✚ Une matité franche de bois, occupant tout un hémithorax.
 - ✚ La limite supérieure horizontale atteint ou dépasse l'épine de l'omoplate en arrière et la clavicule en avant.
- ❖ L'auscultation : une abolition du murmure vésiculaire de tout un hémithorax, un souffle pleurétique : n'est jamais retrouvé.



A-5-2) **Radiographie du thorax** : l'épanchement de grande abondance réalisé ;

- ✚ Un hémithorax opaque (opacité très dense) :
 - Homogène, refoulant le médiastin.
 - Sans bronchogramme aérien.
- ✚ Un effacement de la coupole diaphragmatique.
- ✚ Avec déplacement inférieur des viscères sous-diaphragmatiques homolatérales.



A-6) Pleurésie de moyenne abondance :

✚ Représente la forme la plus fréquente et la plus typique

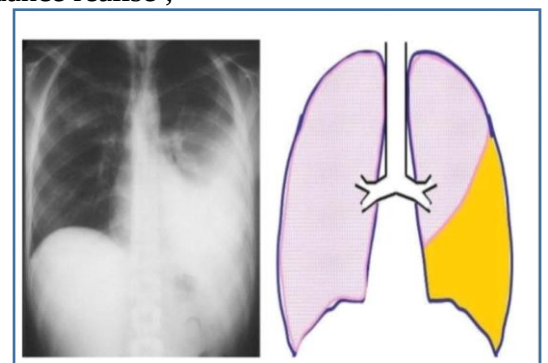
A-6-1) **Examen physique** : comporte plusieurs volets, on retrouve à ;

- ❖ L'inspection : diminution de l'ampliation thoracique homolatérale, dilatation de l'hémithorax atteint, élargissement des espaces intercostaux.
- ❖ La palpation : une abolition des vibrations vocales.
- ❖ La percussion ++ : représente le temps fondamental de l'examen.
 - Une matité franche de bois.
 - La limite supérieure a la forme d'une courbe parabolique à sommet axillaire.
- ❖ L'auscultation : met en évidence ;
 - Une abolition du murmure vésiculaire.
 - Un souffle pleurétique : inconstant, doux, lointain, expiratoire, étendu à la limite supérieure de la matité.



A-6-2) **Radiographie du thorax** : l'épanchement de moyenne abondance réalisé ;

- ✚ Une opacité dense, homogène, déclive.
- ✚ Effaçant la coupole diaphragme.
- ✚ A limite supérieure floue concave en haut et en dedans (réalisant la courbe de **Damoiseau** radiologique).
- ✚ Cette opacité ne contient pas de bronchogramme aérien.



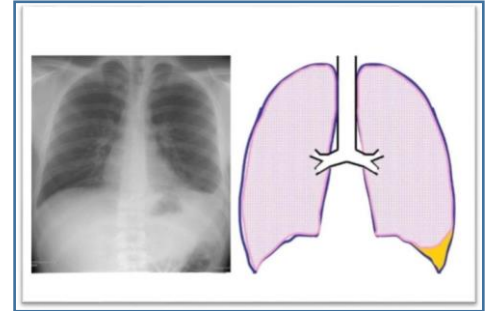
A-7) Pleurésie de faible abondance : la symptomatologie clinique est pauvre.

A-7-1) Examen physique : on retrouve à ;

- ❖ La percussion : une submatité de la base.
- ❖ L'auscultation : met en évidence
 - Une diminution du murmure vésiculaire.
 - Frottements pleuraux localisés : inconstants.

A-7-2) Radiographie du thorax : l'épanchement de faible abondance réalisé ;

- ✚ Le liquide se collecte dans la partie la plus déclive de la plèvre.
- ✚ Cette opacité ne contient pas de bronchogramme aérien.
- ✚ De face : il réalise une opacité qui émousse les culs de sac.
- ✚ Intérêt du cliché de profil : il forme un comblement dans le cul de sac postérieur.
- ✚ L'échographie pleurale : peut aider à confirmer ou à rechercher ces épanchements de faible abondance.



A-8) Cas particuliers :

A-8-1) Les pleurésies cloisonnées ou enkystées : font suite à des symphyses pleurales localisées, isolant certaines régions pleurales. Les poches prennent l'aspect d'une ou plusieurs opacités volontiers enkystées en arrière.

A-8-2) L'épanchement interlobaire : se collecte dans une scissure, formant une opacité fuseau biconvexe, à limites nettes.

A-9) La ponction pleurale :

- ✚ Elle est pratiquée dans un but diagnostique et/ou thérapeutique.
- ✚ On doit respecter les contre-indications.
- ✚ La ponction pleurale permet de :
 - Confirmer la pleurésie : le diagnostic clinique et radiologique devra être confirmé par une ponction pleurale.
 - Faire la distinction entre exsudat et transsudat (la nature du liquide orientera vers différentes étiologies).
 - Assurer un diagnostic présomptif ou définitif.

B) Le syndrome d'épanchement pleural aérien ou pneumothorax

B-1) Définition :

- ✚ Définit la présence d'air dans la cavité pleurale par rupture de la plèvre viscérale.
- ✚ Il est spontané ou secondaire.
- ✚ La forme idiopathique est la plus fréquente et touche avec prédilection les sujets masculins longilignes entre 20 et 30 ans.

B-2) Signes généraux : sont variables selon la maladie sous-jacente, absents dans la forme idiopathique du sujet jeune.

B-3) Signes fonctionnels :

- ✚ Une douleur : à type de point de côté thoracique, d'apparition brutale, parfois en coup de poignard.
- ✚ Aggravé par l'inspiration profonde ou la toux.
- ✚ Une toux : sèche, souvent déclenchée par les changements de position et l'inspiration profonde.
- ✚ La dyspnée est modérée chez le sujet jeune, sauf si le pneumothorax est compliqué.

B-4) Examen physique : comporte plusieurs volets, on retrouve à ;

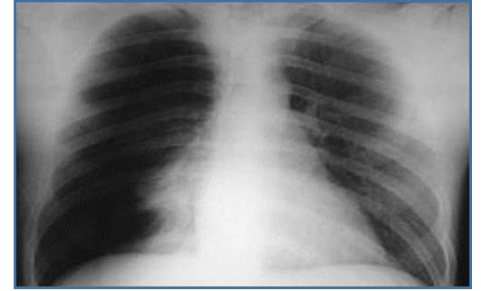
- ❖ L'inspection : une diminution de l'augmentation thoracique ou immobilité de l'hémithorax atteint, avec élargissement des espaces intercostaux.
- ❖ La palpation : une abolition des vibrations vocales.
- ❖ La percussion ++ : représente le temps fondamental de l'examen.

Un tympanisme ou augmentation de la sonorité normale du côté atteint (comparaison avec le côté sain).

- ❖ L'auscultation : met en évidence une diminution ou abolition du murmure vésiculaire (silence auscultatoire).

B-5) Radiographie du thorax :

- ✚ Il existe une hyperclarté gazeuse périphérique d'un hémithorax :
 - Dépourvue de trame vasculaire.
 - Séparée du parenchyme pulmonaire sous-jacent par un fin liseré opaque correspondant à la plèvre viscérale.
- ✚ Le moignon pulmonaire est rétracté dans la région hilare.



C) Le syndrome d'épanchement pleural mixte (aéro-liquidien)

C-1) Définition :

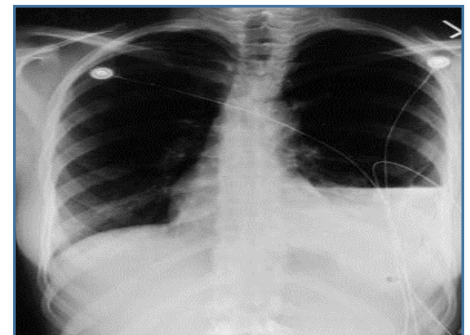
- ✚ Il réalise une complication fréquente du pneumothorax.
- ✚ Selon la qualité du liquide, il s'agira soit :
 - D'un hydro-pneumothorax (liquide clair).
 - D'un pyo-pneumothorax (liquide purulent).
 - D'un hémopneumothorax (liquide hématique).
- ✚ On retrouve des signes d'épanchement liquidien à la base et d'épanchement aérique au sommet.

C-2) Examen physique : comporte plusieurs volets, on retrouve à ;

- ❖ L'inspection : un hémithorax immobile et distendu.
- ❖ La palpation : une abolition des vibrations vocales sur toute l'étendue de l'hémithorax.
- ❖ La percussion ++ : représente le temps fondamental de l'examen.
Une matité franche de bois de la partie inférieure de l'hémithorax à limite supérieure horizontale, surmontée d'un tympanisme ou d'une hypersonorité du côté atteint (comparaison avec le côté sain).
- ❖ L'auscultation : une abolition du murmure vésiculaire (silence auscultatoire) sur toute la hauteur de l'hémithorax.

C-3) Radiographie du thorax :

- ✚ Il existe une opacité franche :
 - Homogène de la base du poumon.
 - Comblant le sinus costo-diaphragmatique.
 - A limite supérieure horizontale.
 - Surmonte d'une hyperclarté.



V. Points à retenir :

- ✚ Il s'agit d'une situation clinique fréquente en médecine générale, en médecine interne et en pneumologie.
- ✚ La plèvre est normalement un espace virtuel contenant une mince couche de liquide pour faciliter le glissement pulmonaire.
- ✚ Le diagnostic est le plus souvent facile : il repose sur l'interrogatoire, l'examen physique et la radiographie thoracique.
- ✚ Les étiologies sont diverses : nécessitant une démarche diagnostique orientée, basée sur un raisonnement sémiologique rigoureux et les résultats de la ponction pleurale.

Différencier les syndromes pleuraux

	Pneumothorax	Pleurésie
Examen	Triade de GAILLARD	Triade de TROUSSEAU
Palpation	Abolition des vibrations vocales	Abolition des vibrations vocales
Percussion ++	Tympanisme ou hypersonorité	Matité franche de bois
Auscultation	Abolition du murmure vésiculaire	Abolition du murmure vésiculaire
Radio	Hyperclarté (sans trame) + Liseré pleural	Courbe de Damoiseau

❖ **Références :**

- 1] Benoît Wallaert Référentiel sémiologie - Collège des Enseignants de Pneumologie 2009 p87-92.
- 2] Rose marie Hamladji, précis de sémiologie P 80-83
- 3] Tazi-Mezalek Ret al. Pleurésie. EMC - Traité de Médecine Akos 2017;12(4):1-7 [Article 6-0685].
- 4] M. Raphael. Ponction pleural. Journal Européen des Urgences et de Réanimation 2014;26, 52-54.